

ANTENATAL ASSESSMENT

تقييم ما قبل الولادة

Introduction | مقدمة

English	العربية
Antenatal care is the care given to the pregnant woman from the time pregnancy is confirmed until labour begins. It includes: following the progress of the pregnancy, supporting the woman, and giving her information so she can make good choices.	رعاية ما قبل الولادة هي الرعاية التي تُقدَّم للمرأة الحامل من وقت تأكيد الحمل حتى بداية المخاض. وتشمل: متابعة تطور الحمل، ودعم المرأة، وإعطائها المعلومات التي تساعد على اتخاذ قرارات سليمة.

Definitions | التعريفات

English	العربية
Antenatal assessment: A regular, step-by-step medical check and follow-up of the pregnant woman during pregnancy. Antenatal care: The care given to the expected mother from the time pregnancy is confirmed until the beginning of labour.	تقييم ما قبل الولادة: هو الفحص الطبي المنظم والمستمر ومتابعة المرأة الحامل طوال فترة الحمل. رعاية ما قبل الولادة: هي الرعاية المقدمة للأم الحامل منذ تأكيد الحمل حتى بداية المخاض.

Aims of Antenatal Care | أهداف رعاية ما قبل الولادة

English	العربية
- Promote the mother's health and the normal well-being of the baby (fetus). - Help the midwife/nurse evaluate the physical, psychological and social effects of pregnancy on the woman and her family. - Prepare the woman for labour, breastfeeding (lactation) and baby care. - Recognise complications of pregnancy early and refer the woman to the right member of the team. - Promote, protect and maintain the mother's health during pregnancy.	- تعزيز صحة الأم والسلامة الطبيعية للجنين. - مساعدة القابلة/الممرضة على تقييم تأثيرات الحمل الجسدية والنفسية والاجتماعية على المرأة وأسرتها. - تجهيز المرأة للولادة والرضاعة الطبيعية والعناية بالطفل. - اكتشاف مضاعفات الحمل مبكرًا وتحويل المرأة إلى عضو الفريق المناسب. - تعزيز صحة الأم وحمايتها والحفاظ عليها أثناء الحمل.

English	العربية
• Detect "high-risk" pregnancies and give these mothers special attention. • Reduce anxiety and fear related to pregnancy. • Reduce illness (morbidity) and death (mortality) of mothers and babies.	• اكتشاف حالات الحمل "عالية الخطورة" وإعطاء هؤلاء الأمهات اهتمامًا خاصًا. • تقليل القلق والخوف المرتبطين بالحمل. • تقليل نسبة المرض والوفاة عند الأمهات والأطفال.

Trimesters of Pregnancy | مراحل الحمل (الأثلث)

English	العربية
• 1st trimester: until 14 weeks. • 2nd trimester: 15 – 28 weeks. • 3rd trimester: 29 – 40 weeks.	• الثلث الأول: حتى الأسبوع 14. • الثلث الثاني: من الأسبوع 15 إلى 28. • الثلث الثالث: من الأسبوع 29 إلى 40.

Schedule of Antenatal Visits | جدول زيارات ما قبل الولادة

English	العربية
• Every month during the first 6 months. • Every 2 weeks during the 7th and 8th months. • Every week during the last month (9th month). Note: more frequent visits are needed in high-risk pregnancy.	• كل شهر خلال الأشهر الستة الأولى. • كل أسبوعين خلال الشهر السابع والثامن. • كل أسبوع خلال الشهر الأخير (التاسع). ملحوظة: في الحمل عالي الخطورة تكون الزيارات أكثر تكرارًا.

Components of Antenatal Care | مكونات رعاية ما قبل الولادة

English	العربية
• History taking. • Physical examination (general and local). • Investigations (tests).	• أخذ التاريخ المرضي (السؤال عن الحالة). • الفحص البدني (الفحص العام والفحص الموضعي). • الفحوصات والتحاليل.

الإجراء الأول: أخذ التاريخ المرضي والفحص البدني | Procedure 1: History Taking & Physical Examination

نظرة سريعة على الإجراء	Procedure at a glance
ما هو؟ مقابلة كاملة وفحص شامل للمرأة الحامل من الرأس إلى القدم أثناء زيارتها.	What is it? A full interview and head-to-toe check of the pregnant woman during her visit.
ماذا نفعل؟ 1) نسألها عن صحتها وحملها السابق (التاريخ المرضي). 2) نفحص جسمها (الفحص العام). 3) نفحص بطنها (الفحص الموضعي: النظر – الجس – السمع).	What do we do? 1) Ask about her health and past pregnancies (history). 2) Examine her body (general examination). 3) Examine her abdomen (local examination: inspection – palpation – auscultation).
لماذا نفعله؟ للحصول على معلومات أساسية، واكتشاف المشاكل مبكرًا، ومنع المضاعفات، وتقديم الرعاية المطلوبة.	Why do we do it? To get baseline data, find problems early, prevent complications and give the care she needs.

التعليل (ليه؟)	Rationale (Why?)	الخطوات	Steps	No. م
الجزء الأول: أخذ التاريخ المرضي				
إظهار الاهتمام وبناء علاقة مهنية جيدة.	To show interest and start a good professional relationship.	رحبي بالسيدة وعرفي بنفسك باسمك ووظيفتك.	Welcome the woman and introduce yourself by name and job title.	1
لتوفير الوقت والمجهود.	To save time and effort.	جهزي الأدوات اللازمة.	Prepare the equipment.	2

No. م	Steps	الخطوات	Rationale (Why?)	التعليل (ليه؟)
3	History taking Take a complete history from the woman: - Personal history & identification data: age, marital status, education, occupation, family members, housing, health habits (smoking, drinking, drugs). - Past medical history: diabetes, hypertension, heart disease, rheumatic fever, etc. - Surgical history: any operation, injury or accident, history of blood transfusion. - Family history: hypertension, heart disease, diabetes, congenital anomalies (birth defects), chromosomal abnormalities. - Menstrual history: age of menarche (first period), date of last menstrual period (LMP), expected date of delivery (EDD), duration of each period, complaints such as dysmenorrhea (painful periods), amount of blood flow. - Obstetrical history: nature of previous pregnancies, labour and puerperium (period after birth), condition and sex of the newborn. - History of complications during pregnancy: type of complication, onset, duration, care given to the mother. - Ask about blood group and Rh type.	أخذ التاريخ المرضي أسألي السيدة عن تاريخها الكامل: - البيانات الشخصية: السن، الحالة الاجتماعية، التعليم، الوظيفة، أفراد الأسرة، السكن، العادات الصحية (التدخين، الكحول، المخدرات). - التاريخ المرضي السابق: السكر، الضغط، أمراض القلب، الحمى الروماتيزمية... إلخ. - التاريخ الجراحي: أي عملية جراحية، إصابة أو حادث، نقل دم. - التاريخ العائلي: الضغط، أمراض القلب، السكر، التشوهات الخلقية، الاضطرابات الكروموسومية. - تاريخ الدورة الشهرية: سن أول دورة، تاريخ آخر دورة (LMP)، موعد الولادة المتوقع (EDD)، مدة الدورة، أي شكاوى مثل ألم الدورة، كمية الدم. - التاريخ التوليدي: طبيعة الحمل السابق، الولادة والنفاس، حالة المولود وجنسه. - مضاعفات أثناء الحمل: نوع المضاعفة، متى بدأت، مدتها، الرعاية التي تلقتها الأم. - أسألي عن فصيلة الدم وعامل Rh.	- To obtain baseline data. - To detect and prevent any complications. - To provide care as required.	- للحصول على بيانات أساسية. - لاكتشاف أي مضاعفات ومنعها. - لتقديم الرعاية حسب الحاجة.
Part 2: Physical examination – (A) General examination				
				الجزء الثاني: الفحص البدني – (أ) الفحص العام
4	Measure weight and height accurately. Tell the woman: total weight gain during pregnancy is about 11 kg.	قيسي الوزن والطول بدقة. أخبري السيدة: الزيادة الكلية في الوزن أثناء الحمل حوالي 11 كجم.	To get a baseline for comparing weight gain during pregnancy.	للحصول على قياس أساسي لمقارنة زيادة الوزن أثناء الحمل.

No. م	Steps	الخطوات	Rationale (Why?)	التعليل (ليه؟)
5	Measure the vital signs correctly (temperature, pulse, respiration, blood pressure).	قيسي العلامات الحيوية بشكل صحيح (الحرارة، النبض، التنفس، ضغط الدم).	It gives a baseline for comparing future measurements.	تعطي قياسًا أساسيًا لمقارنة القياسات القادمة.
6	Help the woman lie in a comfortable position on the examination table.	ساعدني السيدة على الاستلقاء في وضع مريح على سرير الكشف.	For her comfort and to make the examination easier.	لراحتها ولتسهيل الفحص.
7	Explain the procedure to the woman.	أشرحني الإجراء للسيدة.	To gain her cooperation.	لكسب تعاونها.
8	Drape the woman and keep the door, windows and curtains closed. Always keep privacy.	غطّي السيدة وأبقي الباب والشبابيش والستارة مغلقة. حافظي على الخصوصية دائمًا.	To provide privacy, which helps her relax.	لتوفير الخصوصية مما يساعدها على الاسترخاء.
9	Wash your hands and stand on the right side of the woman.	اغسلي يديك وقفي على الجانب الأيمن للسيدة.	To prevent infection.	لمنع العدوى.
10	Examine the head: - Check her hair for lice. - Check the face for pallor (paleness), cyanosis (bluish colour), edema (swelling) and note her facial expression. - Check the conjunctiva (inside of the lower eyelid) for redness or paleness. - Note any pigmentation on the forehead and cheeks. - Examine the mouth for any problem in the gums and teeth.	افحصي الرأس: - تأكدي من خلو الشعر من القمل. - افحصي الوجه بحثًا عن شحوب أو زرقة أو تورم، ولاحظي تعبيرات وجهها. - افحصي الملتحمة (باطن الجفن السفلي) بحثًا عن احمرار أو شحوب. - لاحظي أي تصبغات على الجبهة والخدين. - افحصي الفم بحثًا عن أي مشاكل في اللثة والأسنان.	- To be alert for anemia, pregnancy-induced hypertension and psychological problems. - Swelling of the gums may be normal (physiological) because of the effect of estrogen.	- للانتباه لوجود أنيميا أو ارتفاع ضغط الحمل أو مشاكل نفسية. - تورم اللثة قد يكون طبيعيًا بسبب تأثير هرمون الإستروجين.
11	Examine the neck: - Palpate (feel) the lymph nodes below the back angle of the jaw. - Check the neck for the thyroid gland.	افحصي الرقبة: - تحسّسي الغدد الليمفاوية أسفل الزاوية الخلفية للفك. - افحصي الرقبة للتأكد من حالة الغدة الدرقية.	- Swollen, tender nodes may indicate acute infection or cancer. - To detect any swelling or tenderness.	- تورم الغدد مع الألم قد يدل على عدوى حادة أو سرطان. - لاكتشاف أي تورم أو ألم.
12	Examine the chest: - Assist with examination of the heart and lungs by preparing the woman. - Examine the breasts, nipples and areola.	افحصي الصدر: - ساعدني في فحص القلب والرئتين بتجهيز السيدة. - افحصي الثدي والحلمة والهالة (المنطقة الداكنة حول الحلمة).	- To detect any heart murmur or lung disease. - Refer to the breast examination procedure.	- لاكتشاف أي لغط بالقلب أو مرض بالرئة. - ارجعي لإجراء فحص الثدي.

No. م	Steps	الخطوات	Rationale (Why?)	التعليل (ليه؟)
13	Examine the extremities (hands and legs): - Check the colour of the palms and nails. - Check for swelling of the fingers. - Check for edema over the tibia (shin), ankle and feet. - Look at the legs for dilated veins.	افحصي الأطراف (اليدين والرجلين): - افحصي لون راحة اليد والأظافر. - افحصي وجود تورم في الأصابع. - افحصي وجود تورم (وذمة) على عظمة الساق والكاحل والقدمين. - لاحظي وجود دوالي (أوردة متسعة) في الساقين.	- Pallor may suggest anemia; cyanosis may indicate heart disease. - To detect early signs of pregnancy-induced hypertension. - To detect varicose veins (varicosities).	- الشحوب قد يدل على أنيميا، والزرقة قد تدل على مرض في القلب. - لاكتشاف العلامات المبكرة لارتفاع ضغط الحمل. - لاكتشاف الدوالي.
14	Assist with the pelvic examination.	ساعدني في فحص الحوض.	To help the doctor assess the pelvis and the genital tract.	لمساعدة الطبيب في تقييم الحوض والجهاز التناسلي.
15	Check the woman for danger signs of pregnancy: - Vaginal bleeding. - Gush of water (rupture of membranes). - Stopping of fetal movement. - Continuous headache. - Blurred vision. - Fever.	اسألي السيدة عن علامات الخطر أثناء الحمل: - نزيف مهبل. - نزول ماء بغزارة (تمزق الأغشية). - توقف حركة الجنين. - صداع مستمر. - زغللة (عدم وضوح) في الرؤية. - حمى.	Danger signs mean the mother or baby may be at risk – report them and refer immediately.	علامات الخطر تعني أن الأم أو الجنين قد يكونان في خطر – يجب الإبلاغ والتحويل فوراً.
(B) Local examination (abdominal examination): Inspection – Palpation – Auscultation				
(ب) الفحص الموضعي (فحص البطن): النظر – الجس – السمع				
16	Start the local (abdominal) examination: - Inspection - Palpation - Auscultation (Full steps are in Procedure 2.)	ابدئي الفحص الموضعي (فحص البطن): - النظر (المعاينة) - الجس (اللمس) - السمع (الخطوات الكاملة في الإجراء الثاني.)	To assess the size of the uterus, the position of the baby and its heart rate.	لتقييم حجم الرحم ووضع الجنين ونبض قلبه.
17	Inspection: - Contour (shape) and size of the abdomen. - Scars of previous operations. - Signs of pregnancy. - Fetal movement.	النظر (المعاينة): - شكل وحجم البطن. - ندبات عمليات سابقة. - علامات الحمل. - حركة الجنين.	To get a general idea of the uterine size, the baby's lie and previous surgery (e.g. cesarean section).	لتكوين فكرة عامة عن حجم الرحم ووضع الجنين وأي جراحة سابقة (مثل القيصرية).

No. م	Steps	الخطوات	Rationale (Why?)	التعليل (ليه؟)
18	Palpation: Leopold's maneuvers (see details in Procedure 2).	الجنس: مناورات ليوبولد (التفاصيل في الإجراء الثاني).	To know the fetal lie, presentation, position and engagement.	لمعرفة وضع الجنين وتقدمه وموقعه ونزول الرأس في الحوض.
19	Auscultation of fetal heart sounds (FHS): - At 10 weeks: by Sonicaid (Doppler). - At 20 weeks: by Pinard fetal stethoscope.	سمع نبض قلب الجنين (FHS): - عند 10 أسابيع: بجهاز السونيكيد (دوبلر). - عند 20 أسبوعاً: بسماعة بينارد الخاصة بالجنين.	To check that the baby is well.	للتأكد من سلامة الجنين.

Investigations (Tests) | الفحوصات والتحاليل

English	العربية
Routine investigations: - Urine analysis: for protein (albumin), sugar (glycosuria) and pus cells. - Blood tests: Hb, RBCs, ABO blood group and Rh. - Blood glucose level. - RPR (Rapid Plasma Reagin): a screening test for syphilis. - Virology (tests for viral infections). Other investigations: - Amniocentesis. - Ultrasound scans. - Stress tests. - Non-stress tests.	الفحوصات الروتينية: - تحليل البول: للبروتين (الزلال) والسكر والصديد. - تحاليل الدم: الهيموجلوبين، كرات الدم الحمراء، فصيلة الدم ABO وعامل Rh. - مستوى السكر في الدم. - تحليل RPR: اختبار فحص للزهري (السفلس). - تحاليل الفيروسات. فحوصات أخرى: - بزل السائل الأمنيوسي (أخذ عينة من ماء الرحم). - الموجات فوق الصوتية (السونار). - اختبار الإجهاد (Stress test). - اختبار اللاإجهاد (Non-stress test).

الإجراء الثاني: فحص البطن (مناورات ليوبولد) | Procedure 2: Abdominal Examination (Leopold's Maneuvers)

نظرة سريعة على الإجراء	Procedure at a glance
ما هو؟ فحص بطن الحامل بالنظر (المعاينة) واللمس (الجس) والسمع.	What is it? Examining the pregnant abdomen by looking (inspection), feeling (palpation) and listening (auscultation).
ماذا نفعل؟ ننظر للبطن، ونقيس ارتفاع قاع الرحم، ونؤدي مناورات ليوبولد الأربع بأيدينا، ثم نسمع قلب الجنين.	What do we do? Look at the abdomen, measure the fundal height, do the four Leopold's maneuvers with our hands, then listen to the baby's heart.
لماذا نفعله؟ • لتأكيد الحمل. • لتقدير عمر الحمل. • لاكتشاف أي خلل مثل زيادة ماء الرحم (Polyhydramnios) أو قلته (Oligohydramnios).	Why do we do it? - To confirm pregnancy. - To estimate the age of the pregnancy (gestation). - To detect any abnormality, e.g. polyhydramnios (too much amniotic fluid) or oligohydramnios (too little amniotic fluid).

ارتفاع قاع الرحم | Fundal Height

العربية	English
أسباب انخفاض ارتفاع قاع الرحم (أقل من المتوقع): - خطأ في تاريخ آخر دورة. - قلة ماء الرحم. - وفاة الجنين داخل الرحم. - ضعف نمو الجنين داخل الرحم. - وضع غير طبيعي للجنين مثل الوضع المستعرض.	Causes of LOW fundal height (smaller than expected): - Wrong LMP (wrong dates). - Oligohydramnios. - Intrauterine fetal death. - Intrauterine growth retardation (IUGR). - Malpresentation, e.g. transverse lie.

العربية	English
أسباب ارتفاع ارتفاع قاع الرحم (أكبر من المتوقع): - خطأ في تاريخ آخر دورة. - حمل توأم. - زيادة ماء الرحم.	Causes of HIGH fundal height (bigger than expected): - Wrong LMP. - Twin pregnancy. - Polyhydramnios.

English	العربية
• Macrosomic (very big) baby. • Fetal malformations.	• جنين كبير الحجم. • تشوهات الجنين.

Leopold's Maneuvers | مناورات ليوبولد

English	العربية
Leopold's maneuver is a step-by-step method of inspection and palpation of the abdomen to find out the fetal position, presentation, lie, attitude and engagement. It is best done after 24 weeks of pregnancy, when the outline of the baby can be felt.	مناورة ليوبولد طريقة منظّمة (خطوة بخطوة) لمعاينة البطن وجسّها لمعرفة وضع الجنين وتقدّمه واستلقائه وانتنائه ونزوله في الحوض. والأفضل إجراؤها بعد الأسبوع 24 من الحمل، عندما يمكن الإحساس بشكل الجنين.

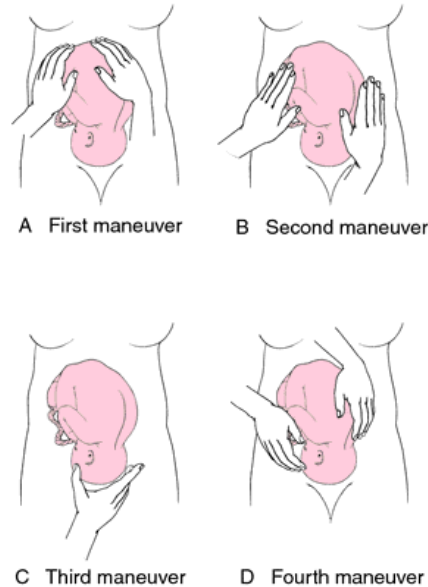
The Four Maneuvers | المناورات الأربع

English	العربية
1st maneuver – Fundal grip: Feel the top of the uterus (fundus) to know its height and which part of the baby is there. It tells us the presentation (cephalic or breech) and the lie (longitudinal, transverse or oblique). Note: if you feel the head, the baby is in breech presentation. If you feel the buttocks, the baby is in vertex (head-down) presentation. 2nd maneuver – Umbilical (lateral) grip: Feel the sides of the uterus to find the baby's back and limbs (right or left side of the mother) and to know the lie. 3rd maneuver – Pawlik's grip: Feel the lower part of the uterus to know whether the presenting part has entered the pelvis (engagement). Note: if the presenting part moves, is round and ballotable (can be pushed and bounces back), it is NOT yet engaged. If it is fixed and does not move, it is engaged. If it is firm, it is the head; if soft, it may be the breech. 4th maneuver – Pelvic grip: Feel the lower part of the uterus (facing the mother's feet) to know the attitude (how much the baby's head and body are flexed).	المناورة الأولى – مسكة قاع الرحم: نتحسس أعلى الرحم (القاع) لمعرفة ارتفاعه وأي جزء من الجنين موجود فيه. وتوضح لنا تقدّم الجنين (رأس أو مقعدة) واستلقائه (طولي أو مستعرض أو مائل). ملحوظة: إذا شعرت بالرأس فالجنين في وضع المقعدة. وإذا شعرت بالمقعدة فالجنين في وضع الرأس (Vertex). المناورة الثانية – المسكة الجانبية: نتحسس جانبي الرحم لمعرفة مكان ظهر الجنين وأطرافه (يمين أم يسار الأم) ولمعرفة استلقاء الجنين. المناورة الثالثة – مسكة بافليك: نتحسس الجزء السفلي من الرحم لمعرفة هل دخل الجزء المتقدم إلى الحوض (انغراس/نزول الرأس). ملحوظة: إذا كان الجزء المتقدم يتحرك ومستديرًا ويرتد عند دفعه (Ballotable) فهو لم ينزل بعد. وإذا كان ثابتًا لا يتحرك فقد نزل. إذا كان صلبًا فهو الرأس، وإذا كان لينًا فقد يكون المقعدة. المناورة الرابعة – مسكة الحوض: نتحسس الجزء السفلي من الرحم (وأنت في مواجهة قدمي الأم) لمعرفة انتثناء الجنين (درجة انتثناء الرأس والجسم). ملحوظة: إذا نزل الرأس بعمق فلن يلمس منه إلا جزء صغير. وإذا كان بروز الرأس (Cephalic prominence) في نفس جهة الأطراف الصغيرة فالرأس منثنٍ. وإذا كان في نفس جهة ظهر الجنين فالرأس منبسط.

English	العربية
Note: if the head has descended deeply, only a small part of the head can be felt. If the cephalic prominence (bump of the head) is on the same side as the small parts (limbs), the head is flexed. If it is on the same side as the baby's back, the head is extended.	

كيف تتعرفين على أجزاء الجنين (ماذا تحسّين) | Criteria of Findings (what you feel)

English	العربية
- Head: hard, firm, round, smooth, ballotable; the groove of the neck may be felt. - Buttocks: less defined, soft, large and NOT ballotable. - Knees and elbows: small irregular parts, nodular with many angles and bumps. - Fetal back: smooth, hard, like a resistant surface.	- الرأس: صلب وثابت ومستدير وأملس ويرتد عند دفعه، وقد يُحسّ أخدود الرقبة. - المقعدة: أقلّ تحديداً، لينة وكبيرة ولا ترتد عند دفعها. - الركبتان والمرفقان: أجزاء صغيرة غير منتظمة، بها نتوءات وزوايا كثيرة. - ظهر الجنين: أملس وصلب مثل سطح مقاوم.



The four Leopold's maneuvers: A – First, B – Second, C – Third, D – Fourth

مناورات ليوبولد الأربع: أ – الأولى، ب – الثانية، ج – الثالثة، د – الرابعة

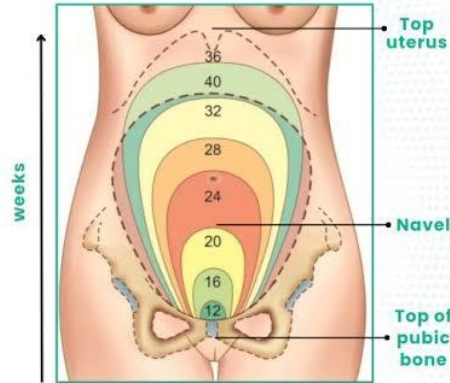
فحص البطن – الخطوات | Abdominal Examination – Steps

No. م	Steps	الخطوات	Rationale (Why?)	التعليل (ليه؟)
1	Welcome the woman and introduce yourself.	رحّبي بالسيدة وعرفي بنفسك.	For reassurance.	للمطمأنة.
2	Explain the procedure and get the woman's agreement.	اشرحي الإجراء واحصلي على موافقة السيدة.	To obtain verbal consent and cooperation.	للحصول على موافقة شفوية وتعاونها.
3	Wash your hands.	اغسلي يديك.	To prevent infection.	لمنع العدوى.
4	Prepare the equipment and the environment.	جهّزي الأدوات والمكان.	To save time and effort.	لتوفير الوقت والمجهود.
5	Ask the woman to empty her bladder.	اطلبي من السيدة تفريغ المثانة.	A full bladder causes discomfort during the procedure and makes the fundus look higher than expected.	المثانة الممتلئة تسبب انزعاجًا أثناء الفحص وتجعل قاع الرحم يبدو أعلى من الحقيقي.
6	Position the mother flat on her back and raise the head of the bed to 15 degrees.	ضعي الأم مستلقية على ظهرها ثم ارفعي رأس السرير بزاوية 15 درجة.	Abdominal muscles are more relaxed in this position, and the risk of supine hypotension (low blood pressure when lying flat) is reduced.	عضلات البطن تكون أكثر استرخاءً في هذا الوضع، ويقل خطر هبوط الضغط الناتج عن الاستلقاء على الظهر.
7	Provide privacy.	وفّري الخصوصية.	Shows respect and a feeling of self-value.	يُظهر الاحترام ويعزز شعورها بقيمتها.
8	Expose the abdomen, leaving the legs and pubic area covered.	اكشفي البطن مع تغطية الساقين ومنطقة العانة.	To maintain privacy.	للحفاظ على الخصوصية.
9	Stand on the right side of the woman if you are right-handed.	قفي على الجانب الأيمن للسيدة إذا كنتِ تستخدمين اليد اليمنى.	It is good practice to work from this side.	من الأفضل العمل من هذا الجانب.

No. م	Steps	الخطوات	Rationale (Why?)	التعليل (ليه؟)
10	Inspection of the abdomen: Look at the abdomen for: - Size in relation to the period of amenorrhea (time since the last period). - Shape and contour of the abdomen. - Scars. - Skin pigmentation (striae gravidarum = stretch marks, linea nigra = dark line).	معاينة البطن (النظر): لاحظي في البطن: - الحجم بالنسبة لمدة انقطاع الدورة. - شكل ومحيط البطن. - الندبات. - تصبغ الجلد (علامات التمدد، والخط الأسود Linea nigra).	- To get a rough idea of the uterine size and muscle tone. - Fetal lie affects the shape. - Scars may indicate previous surgery, especially cesarean section.	- لتكوين فكرة تقريبية عن حجم الرحم وقوة العضلات. - وضع الجنين يؤثر على شكل البطن. - الندبات قد تدل على جراحة سابقة خاصة القيصرية.
11	Warm your hands.	دقني يديك.	To avoid discomfort to the woman and to avoid causing a contraction.	لتجنب انزعاج السيدة ولتجنب حدوث انقباض في الرحم.
12	Palpation of the abdomen – fundal level: Assess the fundal level: place the ulnar border (little-finger side) of the left hand just below the xiphisternum (lower end of the breastbone) and move downwards to reach the top of the uterus. Expected levels: 12th week: just felt above the symphysis pubis. 20th week: the fundus reaches the umbilicus (fetal heart sounds may be heard here). 24th week: just above the umbilicus. 28th week: lower one-third of the distance between the umbilicus and the xiphisternum. 32nd week: two-thirds of the distance between the umbilicus and the xiphisternum. 36th week: at the level of the xiphisternum. 40th week: sinks back to the level of the 32nd week (because the head engages).	جس البطن – مستوى قاع الرحم: قتمي مستوى القاع: ضعي الحافة الزندية (جهة الخنصر) لليد اليسرى أسفل الناتئ الخنجري (نهاية عظمة القص) وحرّكيها للأسفل حتى تصلي إلى أعلى الرحم. المستويات المتوقعة: - الأسبوع 12: يُحسّ فوق عظمة العانة مباشرة. - الأسبوع 20: يصل القاع إلى مستوى السُرّة (وقد يُسمع نبض الجنين هنا). - الأسبوع 24: فوق السُرّة قليلاً. - الأسبوع 28: الثلث السفلي من المسافة بين السُرّة والناثئ الخنجري. - الأسبوع 32: ثلثا المسافة بين السُرّة والناثئ الخنجري. - الأسبوع 36: عند مستوى الناثئ الخنجري. - الأسبوع 40: ينخفض إلى مستوى الأسبوع 32 (بسبب نزول رأس الجنين في الحوض).	To compare the size of the uterus with the period of amenorrhea (expected pregnancy age).	لمقارنة حجم الرحم بمدة انقطاع الدورة (عمر الحمل المتوقع).

FUNDAL HEIGHT CHART

Learn for Nursing Licensing exams @eNursing_portal



Fundal height chart (weeks of pregnancy)

شكل يوضح ارتفاع قاع الرحم حسب أسابيع الحمل

No. م	Steps	الخطوات	Rationale (Why?)	التعليل (ليه؟)
13	Leopold's maneuvers (palpation): Do the four maneuvers below, one after the other (see the pictures A, B, C, D in the Leopold's section).	مناورات ليوبولد (الجس): أدّي المناورات الأربع التالية واحدة بعد الأخرى (انظري الصور أ، ب، ج، د في قسم ليوبولد).	To find out the lie, presentation, position and engagement of the baby.	لمعرفة استلقاء الجنين وتقدّمه ووضع ونزوله في الحوض.

No. م	Steps	الخطوات	Rationale (Why?)	التعليل (ليه؟)
14	First maneuver (fundal grip): Face the woman's head. Place both hands, palms downwards with the fingers close together, on the fundus and gently feel with the fingertips.	المنورة الأولى (مسكة القاع): قفي في مواجهة رأس السيدة. ضعي اليدين بكفين متجهين للأسفل وأصابع متلاصقة على القاع، وتحسسي بلطف بأطراف الأصابع.	- To find out which part of the baby is in the upper part of the uterus. - Helps to diagnose the lie and presentation.	- لمعرفة أي جزء من الجنين موجود في أعلى الرحم. - تساعد في تشخيص استلقاء الجنين وتقدمه.
15	Second maneuver (lateral palpation): Place one hand on each side of the abdomen. Use one hand to support the uterus and the other to feel; then alternate hands and walk the fingertips of both hands over the abdomen to feel the back.	المنورة الثانية (الجس الجانبي): ضعي يداً على كل جانب من البطن. استخدمي يداً لتثبيت الرحم والأخرى للجس، ثم بدلي اليدين وحركي أطراف الأصابع على البطن لتحسس الظهر.	To locate the baby's back and determine the position.	لتحديد مكان ظهر الجنين ومعرفة وضعه.
16	Third maneuver (Pawlik's grip): Grasp the lower part of the uterus between the thumb and fingers of one hand. Spread the hand wide enough to fit the head. Do not press hard, because this movement causes discomfort if done carelessly.	المنورة الثالثة (مسكة بافليك): امسكي الجزء السفلي من الرحم بين الإبهام والأصابع بيد واحدة. افتحي اليد بما يكفي لاجتواء الرأس. لا تضغطي بقوة لأن هذه الحركة تسبب ألماً إذا أجريت بإهمال.	- Sometimes useful to judge the size and mobility of the head. - If ballottement is felt, the presenting part is not yet engaged. - If it is not felt, the presenting part is beginning to sink into the true pelvis.	- مفيدة أحياناً لتقدير حجم الرأس وحركته. - إذا شعرت بالارتداد (Ballottement) فالجزء المتقدم لم ينزل بعد. - إذا لم يحدث ارتداد فالجزء المتقدم بدأ ينزل في الحوض الحقيقي.
17	Fourth maneuver (pelvic grip): Turn to face the woman's feet. Ask the woman to bend her knees slightly and breathe steadily with her mouth open. Hold the sides of the uterus just below the umbilicus with the fingers close together, pointing downwards and inwards.	المنورة الرابعة (مسكة الحوض): استديري لتواجهي قدمي السيدة. اطلبي منها ثني ركبتيها قليلاً والتنفس بانتظام والفم مفتوح. امسكي جانبي الرحم أسفل السرة مباشرة بأصابع متلاصقة متجهة للأسفل وللداخل.	- To determine the presentation and the entry of the presenting part into the pelvis. - Bent knees and open-mouth breathing help her relax and avoid discomfort.	- لتحديد تقدم الجنين ودخول الجزء المتقدم إلى الحوض. - ثني الركبتين والتنفس بالفم المفتوح يساعدان على الاسترخاء وتجنب الألم.

No. م	Steps	الخطوات	Rationale (Why?)	التعليل (ليه؟)
18	Auscultation of the fetal heart rate: - Place the Pinard fetal stethoscope at a right angle (90°) to the abdomen, about 5 cm above the head, on the side where the back was felt. - Keep your ear in firm contact with the Pinard and do not touch it with your hands while listening. - Normal fetal heart rate: 120 – 160 beats/minute. - Listen carefully and count for 30 – 60 seconds.	سمع معدل قلب الجنين: - ضعي سماعة بينارد بزاوية قائمة (90°) على البطن، على بعد حوالي 5 سم فوق الرأس، في الجهة التي شعرت فيها بالظهر. - اجعلي أذنك ملاصقة بإحكام للسماعة ولا تلمسيها بيدك أثناء الاستماع. - المعدل الطبيعي لقلب الجنين: 120 – 160 نبضة/دقيقة. - استمعي بتركيز وعدّي لمدة 30 – 60 ثانية.	To monitor fetal well-being.	لمتابعة سلامة الجنين.
19	Reassure the mother.	طمّني الأم.	To reduce her anxiety and worry.	لتقليل قلقها وخوفها.
20	Help her to redress in privacy.	ساعديها على ارتداء ملابسها في خصوصية.	To keep her dignity and privacy.	لحفاظ على كرامتها وخصوصيتها.
21	Wash your hands.	اغسلي يديك.	To prevent the spread of infection.	لمنع انتشار العدوى.
22	Document the findings and report any abnormalities.	سجّلي النتائج وأبلغني عن أي أمور غير طبيعية.	For follow-up, continuity of care and early detection of problems.	للمتابعة واستمرارية الرعاية واكتشاف المشاكل مبكراً.